Irritabilidad (fase 3)

La misma matriz y la misma regla que la app (fases 3 y 6): en cada fila, la columna que describe al paciente. Pregunta clave: cuánto tarda en calmarse tras la actividad que lo provoca (minutos → baja; horas → moderada; hasta el día siguiente → alta).

Calculadora e IA
v. 544d2beb

Decide con lo que cuenta el paciente; la exploración lo confirma o lo corrige. Si la exploración contradice el nivel, corrige la fila y anótalo.

	0	1	2
LO QUE CUENTA EL PACIENTE			
Dolor en reposo	0 Ausente	1 Intermitente	2 Presente
Tolerancia al estrés físico	0 Alta	1 Moderada	2 Baja
Tiempo en calmarse Tras la actividad que lo provoca, hasta volver a su nivel previo. Si le despierta: vuelve a dormirse en menos de 30 min → horas; más de 30 min o con medicación → día siguiente (Petersen 2021).	0 Cede en minutos	1 Tarda horas	2 No cede hasta tras una noche
AL EXPLORAR			
Dolor con movimiento	0 Al final del rango con SP	1 Al final del rango	2 Antes del final del rango

Cómo se calcula

El **tiempo en calmarse** marca el suelo: minutos → baja, horas → moderada, día siguiente → alta (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Petersen 2021).

Reposo + movimiento + tolerancia (0–2 cada uno, el número de cada opción) solo pueden subirlo: 0–1 baja, 2–4 moderada, 5–6 alta (criterio propio de PhysiQ, inclinado a lo prudente; no hay cortes publicados).

El nivel es el más alto de los dos. Se calcula con lo contestado y avisa si falta alguna fila, porque quedarse corto es el error peligroso. El impacto en las actividades es gravedad y no cuenta aquí.

Se decide con lo que cuenta el paciente (reposo, tolerancia, tiempo en calmarse); el dolor con movimiento sale de la exploración y lo confirma o lo corrige. El dolor en reposo presente no sube el nivel por sí solo: si no cambia con la postura ni con el movimiento, mira la naturaleza del cuadro y el cribado.

Qué implica cada nivel

Baja

Puede explorarse «hasta el límite», con sobrepresión, si el dolor no es severo (no obliga a interrumpir la actividad) y la naturaleza del cuadro no pide prudencia (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Moderada

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Alta

Explorar «hasta el dolor»: solo hasta donde empieza o aumenta, y quizá un poco más para ver cómo se comporta (Maitland 2005, cap. 6, pp. 101 y 127–128; Hengeveld y Banks 2005, cap. 6, p. 148).

Exploración y tratamiento adaptados para no exacerbarlo; la irritabilidad se confirma en la 2.ª visita, por la reacción a la primera (Maitland 2005, cap. 6, p. 117; Hengeveld y Banks 2005, cap. 8, pp. 191–192).

Es un juicio con margen entre fisioterapeutas (acuerdo del 71 %, kappa 0,39–0,44; Barakatt 2009). Matriz incompleta: el nivel puede quedarse corto. Dolor en reposo presente: si no cambia con la postura ni con el movimiento, piensa en la naturaleza del cuadro (inflamatorio, no mecánico) y revisa el cribado de la fase 2. Que el activo esté más limitado que el pasivo no cuenta para la irritabilidad: es un hallazgo del diagnóstico diferencial (árbol de la región).

El impacto en las actividades (mínima · moderada · alta) es gravedad: se anota aparte, junto al NRS.

Generado desde los datos de la app (data/irritabilidad.js, lib/irritabilidad.js) el 12/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0